

REDIGER UNE OBSERVATION

**Université Constantine 3. Faculté de médecine. Département de médecine
Annexe Faculté de médecine Batna**

REDIGER UNE OBSERVATION MEDICALE (1)

**Dr Kerouaz Nassera
Médecine interne**

**Selon le programme national d'Enseignement de 3ème année médecine.
Année universitaire 2025/2026**

SOMMAIRE

- I. Introduction
 - 1) Définition de l'observation
 - 2) Principes fondamentaux
 - 3) Structure de l'observation
- II. Anamnèse
 - 1) Identification
 - 2) Motif de consultation
 - 3) Antécédents (ATCD)
 - a) ATCD personnel
 - Médicaux
 - Allergies
 - Vaccinations
 - Chirurgicaux
 - Gynéco- obstétriques
 - b) ATCD familiaux
 - 4) Histoire de la maladie:
 - 5) Habitudes de vie
 - 6) Conditions socio-économiques
 - 7) Anamnèse orientée
 - a) Signes généraux
 - b) Signes fonctionnels
- III. Conclusion

REDIGER UNE OBSERVATION

I. Introduction

1) Définition

Savoir rédiger une observation est essentielle, elle doit être claire et précise. C'est un document officiel sur le plan médico-légal, il est considéré comme une trace écrite de l'examen et du problème clinique permettant de justifier la prise en charge. L'observation médicale est aussi nécessaire à différents intervenants et permet de transmettre des informations à d'autres médecins qui doivent prendre en charge le patient dans un autre cadre (spécialité, urgence....)

2) Principes fondamentaux de l'observation:

- Le médecin doit être un bon observateur avoir le souci du détail : remarquer l'aspect pale du patient, semble endormi ou agité.
- Ecrire lisiblement et prendre le temps de rédiger directement au chevet du patient, les observations sont de plus en plus informatisées.
- Eviter les abréviations sauf celles qui sont répertoriées en médecine : HTA, HIC, FRCV...
- Plan doit être bien visible
- Pas de syndromologie en sémiologie mais les signes du syndrome
- Acquisition du vocabulaire médical, éviter les termes non médicaux
- Reconstitution en un ensemble cohérent des informations diffractées en appareil par appareil.

3) Structure de l'observation médicale

Elle comporte plusieurs rubriques dans un ordre précis:

- Date et Identification du clinicien
- Entretien (anamnèse systématique et anamnèse orientée)
- Examen clinique
- Résultats des examens complémentaires déjà effectués : biologie, imagerie, endoscopie ou autre;
- Conclusion: résumé et regroupement syndromique, hypothèses, étiologiques argumentées, conduites à tenir diagnostique et thérapeutique.

II. Anamnèse

L'entretien avec le patient permet de recueillir un certain nombre de données comme l'identification du patient, les signes fonctionnels, le motif de consultation, l'histoire de la maladie, nécessaires au diagnostic.

Il faut s'assurer de la faisabilité de l'anamnèse (patient coopérant, pas d'urgence vitale)

1) Identification

- S'identifier en inscrivant la date de l'observation, le nom et fonction du clinicien (Externe, interne....)
- Données civiles du patient : Nom, nom de jeune fille, prénom, date de naissance, sexe, marié célibataire, enfants
- Adresse/téléphone
- Profession

2) Motif de consultation:

- La raison pour laquelle la personne est venue consulter ou est hospitalisée, il peut s'agir de signes subjectifs (douleur, asthénie) ou objectifs (hématémèse, toux)
- Il peut aussi s'agir d'une hospitalisation programmée : exploration, traitement

Mr, Mme..., âgé de ...consulte pour ou admis au service de.....

REDIGER UNE OBSERVATION

3) Histoire de la maladie:

- Reconstituer de façon chronologique l'histoire récente tout en décrivant la plainte du patient qui peut être recueillie auprès de l'entourage
- Mode d'installation et critères du trouble : date de début, type, durée, localisation, intensité,....)
- Signes associés
- Facteurs déclenchant ou soulageant

Exemple : le début de la symptomatologie semble remonter à (date).... marqué par l'installation

4) Antécédents (ATCD)

a) ATCD personnels

- Médicaux: affections passées, date, traitement
Allergies et traitements reçus
- Vaccinations
- Chirurgicaux: le type d'intervention en termes chirurgicaux, la chronologie, le site anatomique, les éventuelles complications du geste opératoire.
- ATCD gynéco-obstétriques : ménarche (date des premières règles), gestes, parité, date des dernières règles (vérifier l'absence de grossesse si un traitement ou examen radiologique doit être prescrit), avortement, contraception

b) ATCD familiaux, consanguinité, MFH, génétiques, Cancer, mentales, - métaboliques, arbre généalogique si maladies héréditaires

5) Habitudes de vie

- Habitudes alimentaires : régime pour une obésité et ou un diabète et ou une carence
- Loisirs : activité physique
- Facteurs de risque: tabac, dyslipidémie, alcool, HTA, diabète, toxiques

6) Conditions socio-économiques : ou statut épidémiologique

- Conditions géographiques: origine
- Habitat et condition d'habitation : urbaine, rurale, nombre de chambre, nombre de personnes dans la famille, éclairage, source d'eau,
- Notion de contact tuberculeux
- Animaux domestiques : pouvant être source d'allergies ou de transmission de maladies
- Ressources économiques : le patient ne peut se permettre une prise en charge coûteuse, n'a pas les moyens de s'alimenter correctement expliquant par exemple un amaigrissement isolé.
- Situation sociale; divorce, veuvage
- Niveau culturel et scolarisation

7) Anamnèse orientée

- a) Signes généraux: amaigrissement, asthénie, anorexie, fièvre, poids, taille
- b) Signes fonctionnels de chaque appareil (organe) en commençant par la zone d'appel en souffrance ou qui a motivé la consultation

REDIGER UNE OBSERVATION

Préciser les caractéristiques sémiologiques de chaque signe fonctionnel présent et noter aussi les signes absents chez le patient et ceci pour chaque appareil.

- III. Conclusion
Résumé de l'anamnèse